家庭养老床位政策的府际差异与模式研究*

——基于26个市级政策文本的比较分析

李月娥，崔雨楠△

(东北大学 文法学院，辽宁 沈阳 110819)

[摘要] 目的：家庭养老床位作为链接基层医疗服务资源与养老服务的中介，可有效解决社区、机构养老照护资源失配、错配与家庭照护负担过重的问题，对该政策进行量化分析，对完善家庭养老床位政策内容，优化资源配置，推动家庭养老床位建设具有重要意义。方法：收集我国省会及试点成效较好城市出台的共26份家庭养老床位政策文本，运用文本挖掘和PMC指数模型，构建量化指标评价已有政策，并以上海、杭州、长春、苏州作为典型案例，梳理政策特征差异。结果：政策总体评价为合格等级，质量提升潜力较大；主要呈现学习－试验型、回应－赋能型、模仿－指令型三类政策模式；政策PMC指数在空间维度上存在差异，政策一致性呈现出东高西低的阶梯状，东、中、西、东北地区政策在不同层面各具优势。结论：我国家庭养老床位政策应根据各地区政策模式进行针对性改良，强化基层医养结合制度建设，通过科技赋能优化照护资源整合与配置，并大力发展养老产业，培育照护人才。

[关键词] 家庭养老床位；PMC指数模型；医养结合；整合照护；养老服务

[中图分类号] R19；D669.6 [文献标志码] A [文章编号] 1004-4663(2024)09－1066－08

Study on the Intergovernmental Differences and Models of Home－Based Care Bed Policies Based on the Comparative Analysis of 26 Municipal Policy Texts./Li Yue'e, et al.//The Chinese Health Service Management.

Abstract Objective To quantitatively analyze the policy of home－based care beds, improve the policy content, optimize the resource allocation, and advance its development. Methods A total of 26 policy texts on home－based care beds issued by provincial capitals and cities with successful pilot results were collected. Text mining and the PMC index model were utilized to establish quantitative indicators for evaluating the existing policies. Shanghai, Hangzhou, Changchun, and Suzhou were selected as typical cases to identify the differences in policy characteristics. Results The overall policy evaluation received a qualified grade, with significant potential for quality improvement. Three main policy models were identified as learning－experimental model, response－enabling model and imitation－instruction model. The policy PMC index varied in spatial dimensions, showing high policy consistency in the east while lower consistency in the west. Policies in the east, middle, west, and northeast regions demonstrated different levels of advantages. Conclusion It is suggested to improve China's home－based care bed policy according to local policy modes, strengthen the basic medical care system, optimize the integration and allocation of care resources through technology, actively promote the development of the elderly care industry, and cultivate health care professionals.

Author's address School of Humanities and Law, Northeastern University, Shenyang, P. R. China.

Key words home－based care bed; PMC index model; combination of medical and nursing care; integrated care; elderly care service.

1 问题的提出

家庭养老床位对解决养老服务的“最后一公里”问题、缓解家庭照护压力、满足老年人原居安养意愿具有实践性意义。其政策历经从“自下而上”到“自上而下”的发展路径，南京、成都、青岛、桂林等地的先试经验有效推动了国家层面家庭养老床位建设文件的出台。2021年民政部、国家发改委发布的《“十四五”民政事业发展规划》(民发〔2021〕51号)提出，健全建设、运营、管理政策，发展“家庭养老床位”。2022年9月，民政部办公厅、财政部办公厅联合印发《关于做好2022年居家和社区基本养老服务提升行动项目组织实施工作的通知》(民办函〔2022〕60号)，明确提出通过中央专项彩票公益金为失能、半失能老年人建设10万张家庭养老床位提供资金支持。在中央政策的支持和推进下，家庭养老床位建设逐步在全国铺开，并已成为构建居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养康养相结合的养老服务体系的重要组成部分。

由于试点省市经济发展与老龄化状况各不相同，家庭养老床位政策也存在较大差异，其内涵、服务对象与内容、发展程度、实施状况相异，地方家庭养老床位建设成效参差不齐。PMC指数模型作为政策文本分析和评价的主要模型，可有效分析政策内部一致性水平，反映政策单项内容发展差异，对推进我国家庭养老床位建设具有指导意义。

2 文献综述

2.1 家庭养老床位研究

回顾既有文献，家庭养老床位的研究主要集中于以下

* 基金项目：辽宁省社会科学规划基金重点项目“辽宁省养老事业与养老产业协同发展研究”(L23ARK001)

第一作者：李月娥，博士，副教授，liyuee@mail.neu.edu.cn

△通讯作者：崔雨楠，硕士研究生，Cuiyunan0109@163.com

万方数据

方面：

家庭养老床位制度建设研究。国际整合照料理念与我国老龄社会多元共治、家庭病床工作思路、数字中国发展等都对该政策模式的创新起到推动作用[1]，适老服务产业的支撑与协助[2]、照护人员的职业认同[3]、家庭支持[4]必不可少。家庭养老床位具有政策属地化、政策模糊性的特征[5]，存在顶层设计不完善、服务刚需不明确的问题，影响家庭养老床位服务需求及稳定性[6]。

家庭养老床位功能研究。家庭养老床位具有资源整合功能，主要体现在：一是基层医疗护理资源与床位服务的整合[7]，尤其是家庭养老床位与家庭病床的“二床合一”实现了社区层面的医养结合[8]；二是家庭养老床位与长期护理保险的深度融合可有效推进医养结合制度建设[9]，满足老年人失能时使用正式照护服务的期望[10]；三是科技赋能家庭养老床位提升了照护效率与质量。床位远程监测服务既降低护理成本，又提高居家老年人独立生活的质量[11]。家庭养老床位通过智能化信息设备、大数据平台可实现“居家、社区、机构、医养”的有机结合[12]，但大数据、区块链等信息技术目前还未在床位服务中发挥资源整合的优势作用[13]，其数智化管理体系亟待完善。

2.2 PMC 指数模型在养老领域的应用综述

PMC 指数模型因其客观性、多元性特征被运用于养老服务、医疗卫生等领域进行政策分析。养老服务研究主要集中于对中央[14,15]、省级[16]出台的养老服务政策进行量化评价，通过三维分析框架诠释家庭养老支持政策[17]、适老化信息服务政策[18]，适老化卫生服务政策[19]等。在医疗卫生方面，学者运用 PMC 指数模型对福建省老年康复产业政策[20]、慢病管理政策[21]、家庭医生签约服务政策[22]、长期照护保险政策[23]进行评估。

我国家庭养老床位建设仍处于起步阶段，鲜有基于家庭养老床位政策本身的分析。本文运用 PMC 指数模型对我国典型城市的家庭养老床位政策进行量化评价，以期为各省市床位建设提供政策优化建议，完善政策内容，推动中央层面规范政策的设立。

3 家庭养老床位政策量化的 PMC 指数模型构建

Ruiz Estrada 基于“Omnia Mobilis”假设提出了政策建模一致性模型（Policy Consistency Index），简称 PMC 指数模型。他认为，在政策建模中任何相关变量都不应被忽视，建议在政策模型评估中纳入非经济变量等广泛的变量。PMC 指数模型可用于分析政策内部一致性和政策单项的发展水平，有效识别政策的优缺点[24]。

研究借鉴并参照国内学者养老服务政策的相关研究进行变量选取与指标设计，通过客观比较形成评价指标体系，弥补了以往评价方法客观性不足的问题。同时，聚焦于市级家庭养老床位政策的横向比较，与 PMC 指数模型的政策建模一致性内涵相匹配。

3.1 政策样本与资料收集

本文在试点城市人民政府官网、市民政局官网、北大法宝等网站中，以家庭养老床位、家庭照护床位、家庭养老照护床位为关键词进行检索，收集到 2017 年至 2024 年共 37 份家庭养老床位相关政策文本。为保证政策的有效性，遵循以下原则对样本进行筛选：①政策本身必须与家庭养老床位建设高度相关，而非仅在政策内容中提及家庭养老床位；②政策的制定发布者必须为省会城市、直辖市及试点经验丰富、政策试点成效显著的非省会城市的地方政府及其所属部门；③政策文本中必须包含家庭养老床位建设相关的实质性内容，排除招标书、活动通知等不包含家庭养老床位建设具体内容的通知公告。依据以上标准进行筛选，最终得到 26 份有效的政策文本作为本文的研究对象（见表 1）。

表 1 各城市家庭养老床位政策出台情况

城市	文件名称	发布时间
南京	南京市家庭养老床位试点实施办法（暂行）宁民规〔2017〕1 号	2017.09
青岛	青岛市居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案青民发〔2022〕96 号	2020.04
苏州	苏州市家庭养老夜间照护床位建设运营管理办法（试行）苏政民老〔2020〕14 号	2020.05
杭州	杭州市家庭养老照护床位试点工作方案杭民发〔2020〕109 号	2020.12
……	……	……
长春	长春市家庭养老床位照护服务实施办法（试行）长民规〔2021〕4 号	2021.11
上海	关于积极推动本市家庭养老床位规范发展的实施意见沪民规〔2023〕11 号	2023.10

3.2 变量选取与参数设置

选取变量、构建评价指标体系及确定各指标参数是 PMC 模型构建的前提。研究将初筛的 26 份家庭养老床位政策文件导入文本数据库，运用 ROSTCM6 软件对政策文本进行分词预处理，并统计高频词及词频（详见表 2，受篇幅限制，本文只展现前 60 个高频词）。

评价指标的选取直接影响 PMC 指数模型政策评价结果的合理性、有效性。研究通过高频词分类，利用 ROSTCM6 软件建立社会网络图谱（如图 1 所示），了解政策文本内容的核心结构及关键词之间的辐射链接程度，为变量参数设置提供依据。

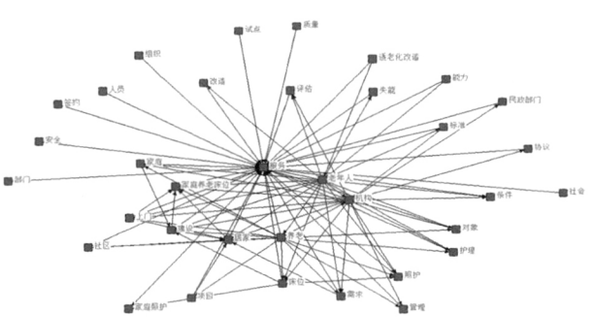


图 1 家庭养老床位政策社会网络关系图谱

万方数据

构建出涵盖政策性质、持续时效、政策内容、激励约束、政策客体、政策主体、政策监管部门数量、政策创新、政策功能、政策公开10个一级变量及生活照料、医疗护理、精神慰藉等42个二级变量的PMC评价指标体系(如表3所示)。

评估体系建立后,需要对变量参数进行设置。其中,所有二级变量重要性及权重均相同,采用二进制进行计算。若待评价的家庭养老床位政策内容与评价标准体系中的二级变量语义近似,则赋值参数为1,反之赋值为0。

表2 家庭养老床位政策高频词及频数

高频词	频率	高频词	频率	高频词	频率	高频词	频率
服务	2649	社区	187	部门	110	保障	75
养老	955	标准	186	享受	109	监测	74
机构	930	需求	179	资助	108	老人	74
老年人	812	失能	176	社会	107	困难	73
居家	476	补贴	167	监管	101	环境	69
家庭养老床位	441	管理	164	安全	93	经济	69
建设	345	资金	148	家庭养老	90	身体	68
床位	327	条件	147	运营	88	等级	66
照护	278	试点	147	发展	86	保险	65
对象	269	人员	138	医疗	86	政府	65
评估	255	适老化改造	129	政策	86	信息化	63
上门	245	家庭照护	127	质量	85	民政	62
家庭	229	民政部门	115	签约	83	监督	61
护理	212	补助	114	方案	82	家属	61
社区	187	协议	114	设施	76	购买	60

表3 家庭养老床位政策变量设置

一级变量	编号	二级变量名称	编号	二级变量名称	编号	来源或依据
政策性质	X_1	监管	$X_{1:1}$	预测	$X_{1:2}$	根据张永安和郄海拓文章修改
		引导	$X_{1:3}$	描述	$X_{1:4}$	
持续时效	X_2	长期	$X_{2:1}$	中期	$X_{2:2}$	根据张永安和周怡园文章修改
		短期	$X_{2:3}$	本年内	$X_{2:4}$	
政策内容	X_3	生活照料	$X_{3:1}$	医疗护理	$X_{3:2}$	
		健康管理	$X_{3:3}$	精神慰藉	$X_{3:4}$	根据Estrada文章修改及文本挖掘
		信息化改造	$X_{3:5}$	适老化改造	$X_{3:6}$	
		辅具支持	$X_{3:7}$	家庭照护者技能培训	$X_{3:8}$	
激励约束	X_4	法律保障	$X_{4:1}$	财政奖补	$X_{4:2}$	根据薛惠元文章修改及文本挖掘
		评估考核	$X_{4:3}$	协议签约	$X_{4:4}$	
		人才培育	$X_{4:5}$			
政策客体	X_5	失能老年人	$X_{5:1}$	半失能老年人	$X_{5:2}$	根据张永安、李放文章修改及社会网络知识图谱
		失智老年人	$X_{5:3}$	特困老人	$X_{5:4}$	
政策主体	X_6	运营经验丰富的养老机构	$X_{6:1}$	社区居家养老服务机构	$X_{6:2}$	根据封铁英文章修改及文本挖掘
		家庭照护者	$X_{6:3}$			
政策监管部门数量	X_7	单部门监督	$X_{7:1}$	两部门联合监督	$X_{7:2}$	根据李月娥文章修改
		三部门及以上综合监督	$X_{7:3}$			
政策创新	X_8	衔接协同	$X_{8:1}$	差异化补贴	$X_{8:2}$	
		信息平台建设	$X_{8:3}$	社会保险衔接	$X_{8:4}$	根据谷明静等文章修改及文本挖掘
		个性化服务	$X_{8:5}$	便民服务	$X_{8:6}$	
		风险保障	$X_{8:7}$			
政策功能	X_9	满足照护需求	$X_{9:1}$	标准体系建设	$X_{9:2}$	根据周正柱等文章修改及文本挖掘
		增强家庭照护功能	$X_{9:3}$	养老服务提质增效	$X_{9:4}$	
政策公开	X_{10}					根据Estrada文章

万方数据

3.3 PMC 指数计算

Estrada 提出，PMC 指数计算主要包括以下四步：①建立多投入产出表；②依据(1)(2)式对评价指标体系中的二级变量进行赋值与加总，计算各二级变量的算术平均值；③根据(3)式将各项二级变量加权，计算一级变量值；④根据(4)式将待评价政策加总得出 PMC 指数，并依据 Kerja 的观点将政策等级划分为四个等级：7.5～9 分的为优秀政策、6～7.5 分的为良好政策、4.5～6 分的可接受政策、0～4.5 分为不良政策。

$$X \sim N[0,1] \tag{1}$$

$$X = \{X_R : [0,1]\} \tag{2}$$

$$X_i = \left(\sum_{j=1}^{n}\right)\frac{X_{ij}}{n} \tag{3}$$

式中，i 表示一级指标，j 为一级指标下的二级指标。

$$PMC = \begin{bmatrix} X_1\left(\sum_{j=1}^{4}\right)\frac{X_{1j}}{4} + X_2\left(\sum_{j=1}^{4}\right)\frac{X_{2j}}{4} + X_3\left(\sum_{j=1}^{8}\right)\frac{X_{3j}}{8} + \\ X_4\left(\sum_{j=1}^{5}\right)\frac{X_{4j}}{5} + X_5\left(\sum_{j=1}^{4}\right)\frac{X_{5j}}{4} + X_6\left(\sum_{j=1}^{3}\right)\frac{X_{3j}}{3} + \\ X_7\left(\sum_{j=1}^{8}\right)\frac{X_{3j}}{8} + X_8\left(\sum_{j=1}^{7}\right)\frac{X_{8j}}{7}X_9\left(\sum_{j=1}^{4}\right)\frac{X_{9j}}{4} + X_{10} \end{bmatrix} \tag{4}$$

3.4 PMC 曲面图绘制

PMC 曲面图能够更加直观地观察政策不同方面的水平。为保证矩阵的对称性，在建立前剔除无二级变量的 X_{10}，保留其他一级变量，建立 3 * 3 的 PMC 矩阵，反映家庭养老床位政策的优劣程度。

$$PMC = \begin{pmatrix} X_1 & X_2 & X_3 \\ X_4 & X_6 & X_6 \\ X_7 & X_8 & X_9 \end{pmatrix} \tag{5}$$

4 家庭养老床位政策量化评价

4.1 政策模型分析

基于 Estrada 提出的 PMC 指数计算方式，对收集的家庭养老床位政策文本进行赋值，计算一级变量并加总，结果显示 26 个城市的 PMC 指数均值为 6.07，政策总体质量为合格等级，其中优秀级 2 项、良好级 11 项、合格级 12 项，较差级 1 项。如表 4 所示：

针对家庭养老床位政策各一级变量而言，由于可获得政策文件内容均为公开，因此 X_{10} 分数不予计算，仅评价其他 9 个一级变量。9 个一级变量 PMC 均值由高到低分别是 X_3、X_1、X_4、X_9、X_6、X_5、X_8、X_7、X_2。

表 4 各城市家庭养老床位政策 PMC 指数及等级

试点城市	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_9	PMC 指数	凹陷指数	排名	等级
上海	1	1	1	0.8	1	1	0.33	1	7.99	1.01	1	优秀
北京	0.75	0.5	1	0.8	1	1	1	1	7.76	1.37	2	优秀
海口	1	0.75	0.88	0.8	0.75	0.67	0.33	1	7.04	1.96	3	良好
广州	0.75	0.75	0.88	0.8	0.5	1	0.33	1	7.01	1.99	4	良好
武汉	1	0.5	0.88	0.8	0.75	1	0.33	1	6.97	2.03	5	良好
天津	0.75	0	1	0.8	0.75	1	1	1	6.87	2.13	6	良好
沈阳	1	0	0.88	1	0.75	1	0.33	1	6.82	2.18	7	良好
杭州	1	0.5	0.75	0.8	0.75	0.67	0.67	0.75	6.6	2.4	8	良好
昆明	1	0	0.88	0.8	0.75	0.33	1	0.75	6.51	2.49	9	良好
宁波	1	0	1	0.8	0.5	1	0.33	1	6.49	2.51	10	良好
兰州	1	0	0.75	0.8	0.75	0.33	1	0.75	6.24	2.76	11	良好
石家庄	1	0	0.88	0.8	0.75	1	0.33	1	6.19	2.81	12	良好
福州	0.5	1	0.88	0.8	0.5	0.67	0.33	0.5	6.04	2.96	13	良好
呼和浩特	0.75	0	0.88	0.8	1	0.67	0.67	0.5	5.98	3.02	14	合格
郑州	1	0	0.75	0.8	1	0.67	0.33	0.75	5.87	3.13	15	合格
重庆	0.75	0.5	0.88	0.8	0.75	0.67	0.33	0.75	5.86	3.14	16	合格
长春	0.5	0.5	0.75	0.8	0.75	0.67	0.67	0.5	5.71	3.29	17	合格
南京	0.75	0	0.75	0.8	0.75	0.67	0.67	0.75	5.57	3.43	18	合格
成都	0.75	0.5	0.75	0.8	0.5	0.67	0.33	0.75	5.48	3.52	19	合格
济南	0.75	0.25	1	0.8	0.25	0.67	0.33	0.75	5.37	3.63	20	合格
桂林	1	0	0.75	0.8	0.75	0.67	0.33	0.75	5.34	3.66	21	合格
南昌	0.5	0.5	0.88	0.8	0.25	0.67	0.33	0.75	5.25	3.75	22	合格
青岛	0.75	0	0.88	0.8	0.75	0.33	0.33	0.75	5.16	3.84	23	合格
合肥	0.75	0	0.88	0.8	0.75	0.33	0.67	0.5	5.11	3.89	24	合格
南宁	1	0.25	0.63	0.6	0.75	0.33	0.67	0.25	4.77	4.23	25	合格
苏州	0.75	0	0.63	0.8	0.5	0.67	0.33	0.25	4.36	4.64	26	不良
平均值	0.84	0.29	0.85	0.79	0.7	0.71	0.51	0.74	6.07	2.93		

万方数据

4.2　PMC 曲面分析

PMC 曲面图的凹陷水平可有效反映政策的优劣程度，政策等级越高，曲面图的凹陷程度越小。26 项家庭养老床位政策的平均凹陷指数为 2.93，为可接受的凹陷程度。依据 PMC 分值，26 份样本政策可划分为四类等级。

4.2.1　Ⅰ类政策

Ⅰ类为优秀级政策，PMC 均值为 7.875，除 X_7 均值为 0.065，其余各一级变量均值均超过 0.7，政策表现较好，代表城市为上海、北京，以上海为例展示该类政策特征：

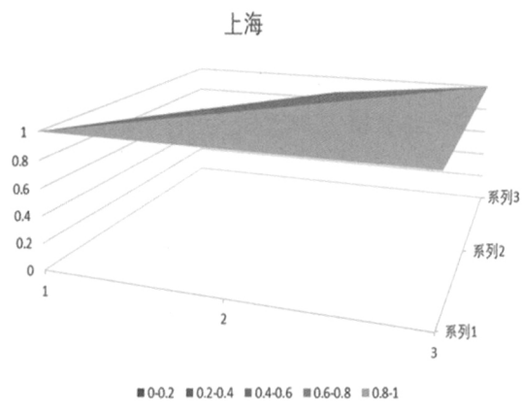


图 2　上海市家庭养老床位政策 PMC 曲面图

上海市家庭养老床位政策 PMC 指数为 7.99。政策在政策性质、持续时效、政策内容、政策作用等方面表现完美。政策连贯性强。上海市于 2019 年率先开展试点，该项政策已持续近 5 年。政策内容丰富。涵盖机构式长期照护、阶段性专项照护、机构设施共享服务、家庭照护增能服务四方面，实现照护资源的精准配置。政策客体覆盖全体老年人，并向部分残疾群体延伸，获益群体持续扩大。在政策作用上，政策以聚焦刚需、整合服务、多元参与为基本原则，通过家庭照护者技能培训提振家庭照护功能。充分借鉴与家庭养老床位近似的家庭病床制度，推动养老服务提质增效。政策激励约束机制健全。上海市是唯一出台正式文件对“以奖代补”制度实施进行明确规定的城市，设立品牌连锁运营奖、家庭照护床位运营奖等，激发养老服务机构建床积极性。政策在人才培育及差异化补贴方面有所欠缺，上海市家庭养老床位政策需通过 X_7—X_4—X_8 路径进行改善。

4.2.2　Ⅱ类政策

Ⅱ类为良好级政策，PMC 均值为 6.63，除 X_2、X_5、X_7 外，其余变量值均超过 0.7，政策整体质量优良，以杭州为例展示此类政策特征：

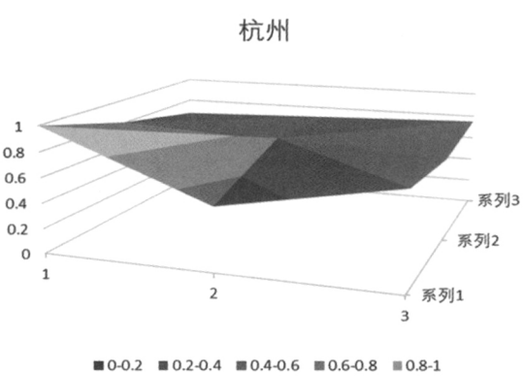


图 3　杭州市家庭养老床位政策 PMC 曲面图

杭州市 PMC 指数为 6.6，各一级变量数值相差不大。政策 X_2、X_3、X_4、X_6、X_8、X_9 方面低于良好级政策 PMC 各一级变量的平均值。

政策主体以养老服务机构为主，正式照护制度与“数智杭州”建设以家庭养老床位为契机进行深度融合，催生出具有杭州特色的数字赋能老年人安居守护的运营机制，并设立养老服务电子津贴“重阳分”，提高老年人服务购买能力。政策医养结合理念浓厚。杭州市积极建设“e 床养老”数字场景，推动“养老床位”和“家庭病床”的有机融合，实现“建床无缝对接、医养服务融合、床位有序转换”的目标，提升服务效率与能级。注重家庭养老床位的标准体系建设。杭州市是国内首个发布家庭养老床位信息化平台建设规范性文件的城市，“养老一张床”服务机制有效推进当地照护资源的整合及基层医联体制度的纵深发展。政策创新方面，未能涵盖社会保险衔接制度、个性化照护服务，政策内容有待完善。因此，杭州市政策改进路径为 X_2—X_6、X_7—X_8—X_3、X_5、X_9—X_4。

4.2.3　Ⅲ类政策

Ⅲ类为合格级政策，PMC 均值为 5.43，政策评级为合格级，以长春为例展示此类政策特征：

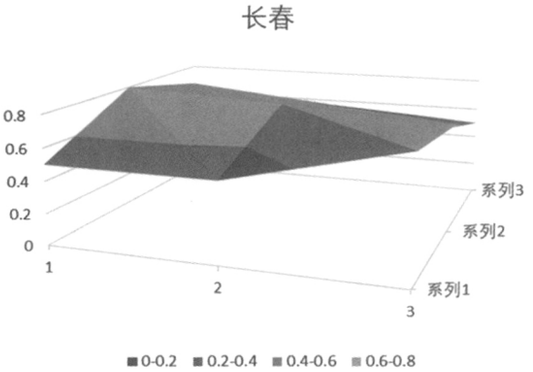


图 4　长春市家庭养老床位政策 PMC 曲面图

长春市家庭养老床位 PMC 指数为 5.71，曲面呈坡状，政策质量不佳。在政策创新方面，实施差异化补贴政策。在规定服务项目和时长范围内，对特困老年人全额补贴，对低保、低收入家庭老年人补贴 90%，个人承担 10%，使该群体能够以较低支出获得床位服务。

政策可持续性弱，床位依托失能人员医疗照护保险开展服务，长护险筹资过度依赖医保资金[25]，医保负担过重。政策监管方面，政策由当地民政、财政部门进行双部门联合监管，医疗保障局监管缺位。因此，政策的改进路径为 X_9—X_1、X_2—X_8—X_6、X_7—X_3、X_5—X_4。

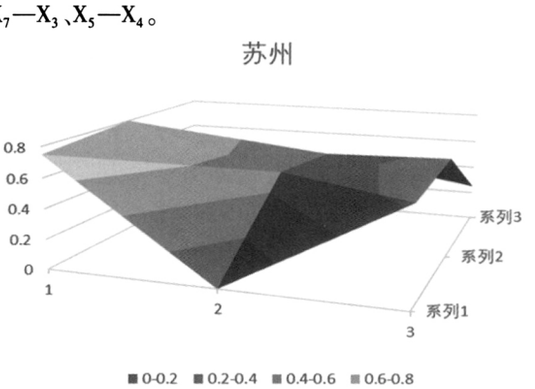


图 5　苏州市家庭养老床位政策 PMC 曲面图

万方数据

4.2.4 Ⅳ类政策

政策样本中，不良级政策仅有苏州一项。苏州市政策完善程度差，政策凹陷指数为4.85，为不可接受的凹陷程度。

苏州市家庭养老夜间照护床位补齐了居家养老“全时服务链”。在政策激励约束方面，创新服务供给模式，鼓励家政公司、物业公司参与老年人夜间照护服务，在社区内建立起专业、稳定的照护队伍，为老年人提供便民服务。

政策客体上，则优先保障高龄、独居、失能等特殊老年人的服务需求，未纳入特困、失智老年群体。政策内容缺乏辅具支持与家庭照护者技能培训。受限于政策服务时间与服务内容，政策不涉及制度衔接协同、差异化补贴等内容。因此，苏州市政策改进路径应为 X_2—X_9—X_7—X_8—X_5—X_4—X_3—X_6—X_1。

4.3 不同空间维度的家庭养老床位政策比较

依据国家统计局标准对26个城市进行地域划分并开展政策分析。东、中、西、东北部地区的PMC指数均值分别为6.34、5.8、5.74、6.27（表6所示）。总体来看，东部地区政策一致性更佳，其次为东北部、中部、西部城市，政策一致性呈现出东高西低的阶梯状。家庭养老床位政策经历了政策发明、试点采用、政策调试与政策融合四阶段，这些阶段并非是线性的，其间可能存在着跨越[26]，该政策在试点过程中呈现出以下政策模式。

表5 各地区家庭养老床位PMC指数

	东部	中部	西部	东北部
X_1 政策性质	0.83	0.81	0.89	0.75
X_2 持续时效	0.37	0.25	0.18	0.25
X_3 政策内容	0.89	0.85	0.79	0.82
X_4 激励约束	0.80	0.80	0.77	0.90
X_5 政策客体	0.67	0.69	0.75	0.75
X_6 政策主体	0.80	0.67	0.52	0.84
X_7 政策监管部门数量	0.49	0.42	0.62	0.50
X_8 政策创新	0.68	0.57	0.57	0.72
X_9 政策作用	0.83	0.75	0.64	0.75
PMC指数	6.34	5.80	5.74	6.27
凹陷指数	2.66	3.20	3.26	2.74
排名	1	3	4	2

4.3.1 学习－试验型政策模式

该模式强调通过学习国内外先进居家照护经验、理念，以地方试点验证政策适配性，继而形塑出政策试验生产政策知识，政策知识改善政策模糊性的良性循环。该模式以老龄化就绪度更高的东部地区城市为代表，包括北京、天津、济南、南京、上海、杭州、广州、福州、海口、青岛、宁波、苏州、石家庄13个城市，具体特征如下：

制度设计理念先行。受到国际整合照护理念的影响，该模式表现为对域外社区居家照护模式的模仿与本土情景的融入。政策内容、政策主体的PMC指数均超过0.8，服务内容、服务对象界定清晰，为建床实施提供指导，激发养老服务主体、客体的制度参与意愿，代表城市有北京、天津、广州、石家庄。以正式照护为主，非正式照护为辅。南京、杭州、青岛等城市倾向提供专业化的正式照护服务；上海、济南、宁波等则鼓励床位服务机构为家庭照护者提供技能培训，将家庭照护等非正式照护制度作为正式照护制度的补充。短期政策试点与府际学习机制验证政策可行性。家庭养老床位政策平均持续时效为1.7年，属于短期政策，有效控制政策风险。该政策由南京率先发起，政策模糊性较强，上海、青岛等地主动响应并建立议题学习机制，政策迅速扩散，有效证明政策可行性，并为政策工具的细化和完善积累经验[27]。

4.3.2 回应－赋能型政策模式

该模式该政策模式是基于东北地区人口老龄化程度及养老资源禀赋所给出的现实回应，以数字赋能弥补地方照护资源不足，形成数字技术与人力资源互补的政策模式，代表城市有长春、沈阳，具体特征如下：

政策情景本土化。东北地区城市老年人社会保险覆盖率高，家庭养老床位基于地方特征进行政策设计，使床位建设与社会保险、医养结合制度衔接，有效提振老年人制度参与意愿，政策本土化程度加深。回应－赋能型政策的激励约束PMC得分为0.9，该政策鼓励养老机构、社区居家养老服务机构、为老服务社会组织、家庭照护者、企业共同参与家庭养老床位制度建设，代表城市为长春、沈阳。政策资源结构丰富化。该类型政策重视制度顶层设计，积极纳入长期照护保险、中央彩票公益金等拓展床位建设筹资渠道，延长制度寿命，代表城市为长春。政策执行数字化。以科技赋能弥补资源不足问题，政府打造“智能看护”服务场景，由平台实时监测老年人健康水平、安全状况，代表城市为沈阳。

4.3.3 模仿－指令型政策

模仿－指令型政策强调在“自上而下”的强行政指令下，政策跟进地模仿政策领先地的经验做法，将其政策模式移植至本地区实施。该模式以中、西部地区为代表，包括成都、重庆、桂林、南昌、呼和浩特、南宁、昆明、兰州、武汉、合肥、郑州11个城市，具体特征如下：

政策行政性强。模仿－指令型政策的政策性质PMC指数为0.89，以强行政指令推进家庭养老床位建设，代表城市有武汉、郑州、南宁、昆明、兰州、桂林。政策监管部门数量的PMC值为0.62，政策平均监管部门数量为两部门。中、西部城市养老资源禀赋不良，设立多部门联合监管机制，以避免政策的象征性执行，代表城市为合肥、南宁、昆明、呼和浩特、兰州。政策趋同化明显。政策扩散具有邻近效应，相近地区在政策风格、内容、目标、工具等方面较为相似，如南昌、合肥、郑州三地均采取强制型政策工具，政策趋同程度较高。

5 家庭养老床位政策的优化路径

家庭养老床位政策正处于从地方试点到全国推广的量变过程，先行试点城市政策在逐渐发生质变，从简单的满足照护需求向数智化整合照护资源转化。分析我国省会及试点经验丰富城市的政策模式差异，总结地方家庭养老床位成功经验，为政策优化提供依据。

5.1 整合地区照护资源，推动医养结合制度建设

家庭养老床位打破了老年人日常生活照料与医疗服务的分治现象，并在制度衔接过程中发挥中介作用，将专业的医疗服务引入居家照护，使老年人日常照料模式与专业医疗照护制度有机结合，形成社会保险、福利、救助相衔接，覆盖全面、分层分类、综合高效的照护保障制度。首先，家庭养老床位建设需要加速与家庭病床、家庭医生等其他医疗领域政策的深度融合，形成“医－养－康－护”一体化的资源发展整合路径[28]。其次，整合地区照护资源，强化民政、卫健、医保、人社等多部

万方数据

门、多机构的有机协同[29]，使失能老年人在卫生服务系统、康复护理机构、养老服务机构、家庭养老床位之间有效衔接，保障服务的连续性和整合性。如上海市静安区打造“五床联动”全流程接续照护模式、广州市越秀区打造中医康养医联体，为我国家庭养老床位整合照护制度建设提供蓝本。

5.2 拓展床位建设资金渠道，扩大制度受益群体

长期护理保险与家庭养老床位服务对象、服务内容高度重合，各地民政、医保部门应统一老年人评估标准，将长护险纳入家庭养老床位结算方式，拓展床位建设资金渠道，并有效避免照护资源的重复性发放。如青岛市的医保、民政部门统一老年人失能评估标准，将家庭养老床位纳入长护险结算，以此缓解政府财政压力。同时，鼓励地方政府建立差异化补贴机制，增强财政可持续性，如长春市依据老年人失能程度发放差异化补贴，提升需求方消费能力，使床位服务流向更需要的人群。另外，拓展家庭养老床位覆盖群体。在服务能力充足的情况下，放宽对失能老年人的经济、户籍条件限制，降低准入条件，使制度受益人群由特困老年人扩展至全体失能、残疾、失智老年人，使更多特殊老年人能够获得专业的原居照护服务。

5.3 搭建智慧养老平台，科技赋能优化照护资源配置

首先，构建区块链与养老服务的有机融合，为家庭养老床位的可持续发展提供了前瞻发展方向。区块链具备去中心化、共识机制、可信任性，可有效保护老年群体数字隐私、加速养老照护、医养结合等信息流动。基于大数据、区块链技术建立起的数智化养老照护平台，可有效实现长期照护服务资源的及时调配，弥补家庭养老床位照护资源的不足，并降低家庭养老床位服务成本。依托数智平台及时识别、处理老年人需求，提升照护服务效率。其次，数字化养老照护平台可有效记录并监督床位服务供给端的服务行为，包括留存上门记录、实时同步服务操作等，帮助政府相关部门履行监管职责，并与用户端的老年人及其家庭成员进行互动，获取床位服务质量评价与反馈。如杭州市通过建立数字赋能家庭养老床位照护管理运行机制，依托信息化系统和智能化设备，实现照护需求与服务的精准配置；沈阳市依托“沈阳养老”小程序，打造“指尖养老”服务模式，在服务结束后充分了解老年人及其家属床位服务满意度。

5.4 促进养老照护产业发展

家庭养老床位依托养老机构开展各项服务，其服务质量、内容等与地方养老产业发展水平息息相关。因此，需大力扶持地方养老产业发展，建立养老事业与养老产业的良性互动机制。国务院办公厅提出要“鼓励和引导国有企业结合主责主业积极拓展银发经济相关业务”，政府应积极编制养老产业发展规划，发挥国资国企资源协同优势，承办养老照护服务相关峰会、博览会等，吸引养老照护企业投资。就失能老年人而言，从医院到家庭养老床位，照护效果变动程度不大，但照护费用可能会大大降低，在减轻“社会性住院”现象的同时，增加养老机构业务量，提升地方养老照护产业发展，形成以家庭养老床位建设为中介的养老事业与养老产业的有机循环。家庭养老床位以社区为支点，促进老年健康、物业服务等养老产业服务相融合[30]，可借鉴苏州“社区 + 物业 + 养老”[31]的床位建设经验，打造家庭养老床位全时段服务。

[参考文献]

[1] 王永梅，武佳，纪竞垚. 我国家庭养老床位发展现状与城市居民需求特征[J]. 社会建设，2023，10(02)：68 - 82.

[2] 高丽萍，李长根. 将养老院里的标准服务送到家：四川省成都市家庭照护床位建设评估与改造实践[J]. 中国社会保障，2023(03)：87.

[3] BAMBER H，MARSHALL K. Barrier sand challenges to integrated care[J]. Clinics In Integrated Care，2023，18：100148.

[4] KOIKE S，FURUI Y. Long - term care - service use and increases in care - need level among home - based elderly people in a Japanese urban area[J]. Health Policy，2013，110(1)：94 - 100.

[5] 李月娥，韩羽佳. 多源流理论视域下家庭养老床位试点政策制定：形成机理与发展趋势[J]. 青海社会科学，2023(02)：105 - 113.

[6] 陈静，刘桃. 家庭养老床位何以解养老之忧[J]. 中国社会保障，2023(03)：84 - 86.

[7] 黄阳珍. 家庭养老床位发展的挑战与对策探析：基于南京的个案研究[J]. 老龄科学研究，2022，10 (12)：50 - 62.

[8] 沈凌，徐庆，钟捷，等. 基于半结构化访谈的家庭病床与家庭照护病床“二床合一”可行性研究及政策建议[J]. 中国初级卫生保健，2023，37(08)：33 - 35.

[9] 乔先华. 青岛市家庭养老床位的探索与实践[J]. 社会福利，2021(08)：31 - 32.

[10] LIU H，MA J Q，ZHAO L Q，Public long - term care insurance and consumption of elderly households：Evidence from China[J]. Journal of Health Economics，2023，102759.

[11] RAJER C，BOGATAJ D，Digital transformation of home care：Literature Review and Research Agenda[J]. IFAC - Papers OnLine，2022，229 - 234.

[12] 孙邦军，陈婷婷. 创建“家庭养老照护床位”失能失智老人享受定制服务[J]. 社会福利，2019(11)：35 - 36.

[13] 章晓懿，马德秀，陈谦谦. 整合照料视角下的老年家庭照护床位政策研究[J]. 今日科苑，2021(07)：3 - 12，25.

[14] 邹钰莹，娄峥嵘. 中央层面养老服务政策内容量化评价：基于 PMC 指数模型的分析[J]. 电子科技大学学报(社科版)，2020，22(03)：68 - 76.

[15] 方永恒，刘佳敏. 国务院养老服务政策挖掘与量化评价：基于 PMC 指数模型分析[J]. 云南行政学院学报，2020，22(05)：167 - 176.

[16] 谷明静，赖佳燕. 基于 PMC 指数模型的我国省级养老服务政策设计的评价[J]. 闽江学院学报，2023，44(03)：68 - 79.

[17] 李放，饶丹，沈苏燕. “工具—主题—属性”框架下家庭养老支持政策量化评价研究[J]. 人口与发展，2023，29(03)：84 - 95.

[18] 刘伊琳. 适老化信息服务政策量化评价研究：基于 PMC 指数模型[J]. 老龄科学研究，2021，9(08)：40 - 54.

[19] 程兆鹏，王高玲. 基于 PMC 指数的智慧医疗背景下我国适老化卫生服务政策量化评价[J]. 中国医院，2023，27(08)：57 - 60.

[20] 冯杰，吴心怡. 基于 PMC 指数模型的福建省老年康复产业政策评价体系构建研究[J]. 中国市场，2023(27)：69 - 73.

[21] 赵思琦，刘栋梁，夏毓琦，等. 基于 PMC 指数模型的我国慢病管理政策量化评价[J]. 中国药房，2021，32(13)：1627 - 1633.

[22] 徐萍萍，赵静，李春晓，等. 我国中央层面家庭医生签约服务政策量化评价：基于 PMC 指数模型[J]. 中国全科医学，2023，26(04)：440 - 446.

[23] 薛惠元，张永高. 共同富裕视域下我国长期护理保险政策评价与优化路径研究：基于 PMC 指数模型[J]. 中国卫生政策研究，2023，16(06)：10 - 19.

[24] 张永安，郄海拓. 国务院创新政策量化评价：基于 PMC 指数模型[J]. 科技进步与对策，2017，34(17)：127 - 136.

[25] 吕佳佳，韩烨，沈彤. 东北三省长期护理保险试点评价及对策[J]. 中国人力资源社会保障，2023(02)：37 - 39.

万方数据

[26] LUCAS A. Public Policy Diffusion Research: Integrating Analytic Paradigms[J]. Science Communication, 1983, 4(3):379-408.
[27] 赵慧. 政策试点的试验机制:情境与策略[J]. 中国行政管理,2019(01):73-79.
[28] 汪连新. 医养康护一体化社区养老服务:理念、困境及借鉴[J]. 学习论坛,2019(04):83-88.
[29] 张静,高俊岭,乔晓春. 医养结合的中期照护服务:理念、现存问题及专业化发展路径[J]. 人口与经济,2024(03):30-42.
[30] 杨晓奇. "十四五"时期我国老龄产业发展趋势及思路[J]. 兰州学刊,2022(10):142-151.
[31] 陈杰,张宇,石曼卿. 当前居家社区养老服务体系存在的短板与创新:兼论"社区+物业+养老服务"模式推广问题[J]. 行政管理改革,2022(06):84-93.

[收稿日期] 2024-5-30
(编辑 李 苑)

(上接第1051页)参与过程中,与他人的沟通、对现下事物的关注不仅能填补老人的生活空缺,还能帮助其继续发挥个人价值,提高自我认同感,抑制焦虑、孤独等消极情绪的产生,继而提升对生活的满意度。

研究还发现,性别、自评健康状况、有无社会照料以及自评经济状况对独居老人生活满意度的影响均具有统计学意义。其中,男性生活满意度低的概率大于女性,这可能与男性更依赖配偶等社会关系有关[12];Kim YB、王婷仙和邓大松等人的数据分析结果佐证了健康与老人生活满意度的关系:良好的健康状况有助于减少抑郁情绪的产生以及提高生活质量[9,13,14];社会支持有利于提升老人的生活质量,这与刘传利等人的研究结论一致[15];自评经济状况越好,越可能对生活感到满意,这与黄文静等人、王琼等人的成果相符[16,17]。

独居老人与社会隔离的可能性更大,缺少家人的陪伴会产生更多的孤独感,继而引起抑郁情绪,社会参与对他们的生活质量影响往往更大。提高这一特殊群体的社会参与度不仅有利于提升个人生活满意度,也是响应健康中国、实现积极老龄化战略的应有之义。研究提出以下建议:(1)个人层面。比起被动的社会隔离,老人主动隔离对抑郁情绪的产生作用更大[18]。建议老人积极利用现有条件、扩大社会关系网,保持一定的社会参与强度,培养良好的社交活动习惯从而促进身心健康,以乐观的态度面对晚年生活。(2)基层组织方面。社区或者村委会应充分发挥作用,关注独居老人生活状况,组织多样化的适合老年人的活动,如讲座、兴趣小组等,以增加独居老人的社会参与机会;同时可建立志愿者团队,通过志愿者的陪伴和交流,减少他们抑郁情绪的产生。(3)社会层面。第一,着力宣传社会参与对老人的积极影响,提高其社会参与意识,鼓励独居老人走出家门,不仅有利于提高其生活质量,也能提高他们对社会发展的认识;第二,为老人社会参与营造良好氛围。进一步推进老年人文化交流、就业的建设工作,重点关注独居、贫困等特殊老年群体,为其出台更精细的帮扶政策、提供更加完善的制度保障。

但本研究仍存在一定局限性。首先,本文使用的是截面数据,未能呈现动态行为信息;其次,研究未对社会参与分类型展开深入讨论,不同分类的社会活动参与可能对独居老人生活满意度的影响存在差异,未来的研究可对此进行更深层次的探讨。

[参考文献]

[1] 张艳平. 社会参与对失独老人抑郁度的影响[J]. 中国老年学杂志,2021,41(12):2637-2641.
[2] XINXIN, M. Social participation and self-reported health in China: evidence from Chinese middle-aged and elderly adults[J]. International Journal of Social Economics, 2021,48(1):85-103.
[3] 胡依,李贝. 社会活动参与对流动老人健康的影响研究:基于倾向得分匹配的实证分析[J]. 现代预防医学,2020,47(24):4488-4491.
[4] 孔泽宇. 社会参与对老年人生活质量的影响[J]. 调研世界,2021(04):72-80.
[5] 沈冠辰,王岩. 疫情后独居老人的心理支持研究:基于社会支持理论视角[J]. 长春理工大学学报(社会科学版),2022,35(03):78-83.
[6] 晏月平,李雅琳. 独居老人的多维健康脆弱性研究:基于"中国老年健康影响因素跟踪调查"的实证分析[J]. 云南民族大学学报(哲学社会科学版),2022,39(04):64-75.
[7] 张英英,谭萍芬,范转转,等. 独居老年人抑郁现状及其影响因素分析[J]. 江西中医药,2023,54(05):55-58,64.
[8] 和红,闫辰聿,王鑫,等. 社会参与对中国老年人抑郁水平的影响研究[J]. 中国卫生政策研究,2023,16(02):1-8.
[9] Kim YB, Lee SH. Gender Differences in the Relationship between Living alone and Depressive Symptoms in Elderly Korean Adults[J]. Iran J Public Health, 2019, 48(3):465-473.
[10] 李宗华. 近30年来关于老年人社会参与研究的综述[J]. 东岳论丛,2009,30(08):60-64.
[11] 方杰,张敏强,邱皓政. 中介效应的检验方法和效果量测量:回顾与展望[J]. 心理发展与教育,2012,28(01):105-111.
[12] 刘亚娜,褚琪. 关于独居老年人社会交往及生活满意度的研究:基于对独居老年人"抱团养老"现象的透析[J]. 价格理论与实践,2023(09):86-90,208.
[13] 王婷仙,林艳伟. 社会支持视角下丧偶老年人生命质量的影响因素研究[J]. 中国卫生事业管理,2022,39(10):787-792.
[14] 邓大松,唐嘉梨. 老年人生活满意度及其影响因素研究:基于中国健康与养老追踪调查数据[J]. 理论月刊,2021(12):116-124.
[15] 刘传利,秦文哲,徐凌忠,等. 抑郁在老年人领悟社会支持与生活满意度之间的中介效应[J]. 现代预防医学,2022,49(03):466-471.
[16] 黄文静,符国帅,谭莉娜,等. 城市空巢老人自尊和生活满意度及其影响因素[J]. 中国老年学杂志,2021,41(06):1326-1329.
[17] 王琼,刘晨,侯晓春,等. 居住安排对我国老年人生活满意度的影响效应分析[J]. 现代预防医学,2023,50(12):2195-2200,2214.
[18] Choi H, Irwin MR, Cho HJ. Impact of social isolation on behavioral health in elderly: Systematic review[J]. World J Psychiatry,2015,5(4):432-8.

[收稿日期] 2024-5-15
(编辑 李 苑)

万方数据